

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO BREVE DE PERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD (BIPQ)

Brief Illness Perception Questionnaire (Broadbent et al., 2006) · Validación Española (Pacheco-Huergo et al., 2012)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario Breve de Percepción de la Enfermedad (Brief Illness Perception Questionnaire, BIPQ)
Sigla / Acrónimo	BIPQ (forma abreviada del IPQ / IPQ-R de Weinman et al.)
Autoría original	Elizabeth Broadbent, Keith J. Petrie, Jodie Main & John Weinman (Univ. of Auckland, 2006)
Adaptación en español	Pacheco-Huergo, Viladrich, Pujol-Ribera et al. (2012, Aten Primaria)
Constructo evaluado	Representaciones cognitivas y emocionales subjetivas que el paciente construye sobre su enfermedad
Población diana	Adultos con cualquier enfermedad médica aguda o crónica (diabetes, asma, dolor crónico, cardiopatías)
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (autoadministrado o en entrevista clínica asistida)
Estructura y formato	8 ítems numéricos continuos (0 a 10) y 1 ítem cualitativo abierto sobre las 3 causas atribuidas
Condiciones de uso	Uso libre en el ámbito clínico e investigador no comercial citando a los autores (Univ. of Auckland)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El BIPQ se fundamenta sólidamente en el **Modelo de Autorregulación del Sentido Común (Common Sense Model of Self-Regulation, CSM)** propuesto por Howard Leventhal. Según este modelo, cuando un individuo se enfrenta a una amenaza de salud o experimenta síntomas corporales, desarrolla de manera automática dos representaciones mentales paralelas: una representación cognitiva (qué es la enfermedad, cómo se cura, cuánto durará) y una representación emocional (miedo, ira, tristeza o angustia).

Estas representaciones mentales determinan directamente las estrategias de afrontamiento del paciente (búsqueda de ayuda médica, adherencia terapéutica, cambios en el estilo de vida o abandono) y predicen los resultados clínicos objetivos y la mortalidad con mayor fuerza que la propia gravedad biológica estricta de la patología. El BIPQ fue sintetizado para condensar las extensas escalas del IPQ-R en ocho preguntas directas de rápida administración en consultas médicas.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DEL BIPQ

Ítem	Dimensión Teórica	Escala	Pregunta Operativa y Rango de Puntuación
1	Consecuencias	0 a 10	¿Cuánto afecta su enfermedad a su vida? (0 = Nada; 10 = Afecta severamente)
2	Cronología / Duración	0 a 10	¿Cuánto tiempo cree que durará? (0 = Poco tiempo; 10 = Para siempre)
3	Control Personal	0 a 10	¿Cuánto control cree que tiene sobre ella? (0 = Ningún control; 10 = Control total)
4	Control del Tratamiento	0 a 10	¿Cuánto cree que le ayuda el tratamiento? (0 = Nada; 10 = Extremadamente eficaz)
5	Identidad Sintomática	0 a 10	¿Cuánto experimenta síntomas físicos? (0 = Ningún síntoma; 10 = Síntomas severos)
6	Preocupación	0 a 10	¿Qué tan preocupado/a está por ella? (0 = Nada preocupado; 10 = Extremadamente)
7	Comprensión / Coherencia	0 a 10	¿Qué tan bien comprende su enfermedad? (0 = No la entiendo; 10 = La entiendo muy bien)
8	Respuesta Emocional	0 a 10	¿Cuánto le afecta emocionalmente (tristeza/ira)? (0 = Nada; 10 = Extremadamente)
9	Atribución Causal	Texto libre	Por favor, enumere las 3 causas principales que cree causaron su problema

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN ESPAÑA Y ATENCIÓN PRIMARIA

Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 3-6 semanas con coeficientes de correlación de Pearson y CCI de $r = 0.70$ a 0.85 para los ítems individuales en pacientes estables.
Validez concurrente	Correlaciones moderadas a altas ($r = 0.52 - 0.68$) con las subescalas correspondientes de la versión extensa de 84 ítems del IPQ-R (Pacheco-Huergo et al., 2012).
Validez predictiva	Predice de forma independiente la adherencia terapéutica a hipoglucemiantes y antihipertensivos ($p < 0.01$), la asistencia a programas de rehabilitación y la baja laboral prolongada.
Validez discriminante	Discrimina claramente entre pacientes con afrontamiento activo vs. afrontamiento pasivo/evitativo y entre diferentes fases evolutivas de enfermedades crónicas.
Sensibilidad al cambio	Capaz de registrar modificaciones tras intervenciones psicoeducativas grupales, consultas de enfermería especializada o cambios en el tratamiento médico.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Análisis por ítem individual	La forma más recomendada por los autores es el perfil dimensional ítem por ítem (cada uno refleja una dimensión cognitiva o afectiva pura de 0 a 10).
Ítems invertidos	Para calcular la puntuación total de amenaza, se deben invertir los ítems 3, 4 y 7 : "Ítem Invertido" = 10 - Puntuación Original .
Puntuación global de amenaza	Fórmula: "BIPQ Total" = Ítem 1 + Ítem 2 + (10 - Ítem 3) + (10 - Ítem 4) + Ítem 5 + Ítem 6 + (10 - Ítem 7) + Ítem 8 . Rango teórico: 0 a 80 puntos .
Direccionalidad del total	A mayor puntuación , la enfermedad es percibida como más amenazante , catastrófica, incontrolable e incomprensible por parte del paciente.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Percentil	Representación Percibida	Significación y Pronóstico de Conducta en Salud
0 - 35 puntos	< Pc 35	Baja Amenaza / Benigna	Percepción de alto control personal y terapéutico; excelente autocuidado.
36 - 49 puntos	Pc 40 - Pc 65	Amenaza Moderada / Adaptativa	Percepción equilibrada entre impacto real y capacidad de afrontamiento.
50 - 64 puntos	Pc 70 - Pc 85	Alta Amenaza / Negativa	Desesperanza, baja autoeficacia y temor; riesgo de abandono de tratamiento.
65 - 80 puntos	> Pc 90	Amenaza Extrema / Catastrófica	Creencia de irreversibilidad absoluta y falta total de control; gran estrés.

PATRONES CLÍNICOS CRÍTICOS:

- **Bajo Control Personal (Ítem 3 $\leq$ 3) con Alta Preocupación (Ítem 6 $\geq$ 8):** Predice baja adherencia a pautas de ejercicio y dieta; el paciente se percibe como una víctima pasiva de su patología.
- **Baja Comprensión (Ítem 7 $\leq$ 3):** Requiere intervención psicoeducativa urgente por parte del personal de enfermería para aclarar mitos erróneos sobre la enfermedad.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL MODELO LEVENTHAL

Paso 1: Aplicación del BIPQ en la Consulta Médica o de Enfermería: Analizar tanto el total como el perfil de ítems individuales.

Paso 2: Si el Problema Principal es de Comprensión (Ítem 7 $\leq$ 3): Reestructurar la educación médica del paciente; suministrar material gráfico comprensible y verificar mediante técnica de **teach-back**.

Paso 3: Si el Problema Principal es de Eficacia Terapéutica Percibida (Ítem 4 $\leq$ 3): Explorar expectativas erróneas sobre el tiempo de acción del fármaco (ej. creer que el antidepresivo o broncodilatador de mantenimiento debe curar instantáneamente).

Paso 4: Si el Problema es Emocional Puro (Ítems 6 y 8 $\geq$ 8): Derivar a Psicooncología / Psicología de la Salud para abordaje del trastorno adaptativo comórbido.

Paso 5: Si las Atribuciones Causales (Ítem 9) son Erróneas: Corregir ideas de autoculpa o factores mágicos desadaptativos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA (DIABETES TIPO 2)

Identificación: Paciente varón de 54 años con diagnóstico reciente de Diabetes Mellitus tipo 2 y mal control metabólico persistente (HbA1c = 9.4%), con mala adherencia a metformina y rechazo a modificar su alimentación.

Evaluación BIPQ Inicial: Puntuación Total = **58 / 80** (Percepción muy amenazante).

- Desglose clave: Ítem 1 (Consecuencias) = 9; Ítem 2 (Duración) = 10; Ítem 3 (Control personal) = 1 (sensación de no poder hacer nada); Ítem 4 (Tratamiento) = 2 (creencia de que la medicación le destruirá el hígado); Ítem 7 (Comprensión) = 2 (desconoce el origen de la enfermedad); Ítem 9 (Causas): "Un disgusto laboral y mala suerte genética".

Intervención Psicoeducativa Específica: 3 sesiones individuales de educación terapéutica por enfermería de atención primaria, desmontando mitos sobre la insulina y metformina y entrenándolo en automonitorización capilar.

Reevaluación a los 3 Meses: El Control Personal (Ítem 3) ascendió a 8/10, el Control del Tratamiento (Ítem 4) a 9/10 y la Comprensión (Ítem 7) a 9/10, descendiendo el BIPQ total a **26 / 80** (Baja amenaza). La adherencia a la metformina alcanzó el 95% y la HbA1c descendió al 7.1%.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas en Percepción:

- Negación Peligrosa:** Puntuación extremadamente baja en Consecuencias (0 – 1) con no asistencia a controles (riesgo de complicaciones silentes como nefropatía o retinopatía).
- Desesperanza Extrema:** Puntajes de respuesta emocional = 10 pueden enmascarar ideación suicida reactiva al diagnóstico.

Diagnóstico Diferencial:

- BIPQ vs. IPQ-R:** El BIPQ es una herramienta de cribado y perfilado rápido; si se requiere investigación psicométrica detallada de identidad de síntomas específicos, usar IPQ-R.
- Trastorno de Ansiedad por Enfermedad:** La preocupación sobrepasa ampliamente la gravedad objetiva médica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Broadbent, E., Petrie, K. J., Main, J., & Weinman, J. (2006). The Brief Illness Perception Questionnaire. *Journal of Psychosomatic Research*, 60(6), 631-637. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2005.10.020>
- Pacheco-Huergo, V., Viladrich, C., Pujol-Ribera, E., Cabezas-Peña, C., Núñez, M., Roura-Olmeda, P., & del Val, J. L. (2012). Percepción de la enfermedad en personas con diabetes tipo 2: adaptación transcultural del cuestionario Brief Illness Perception Questionnaire (B-IPQ). *Atención Primaria*, 44(4), 201-208. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2011.02.006>
- Leventhal, H., Phillips, L. A., & Burns, E. (2016). The Common-Sense Model of Self-Regulation (CSM): a dynamic framework for understanding illness self-management. *Journal of Behavioral Medicine*, 39(6), 935-946.
- Broadbent, E., Wilkes, C., Koschwanz, H., Weinman, J., Norton, S., & Petrie, K. J. (2015). A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire. *Psychology & Health*, 30(11), 1361-1385.